

Clasificación de Morris de las relaciones patológicas

Tema 6 · Clasificación de relaciones patológicas

Clasificación de Morris

Está basada en las investigaciones del Dr. H. G. Morris. Sirve para entender cómo la presencia de obstáculos físicos predispone a que una oclusión se vuelva patológica. Describe la **dirección de la desviación mandibular** al cerrar, no la relación molar.

- **Clase I** · relación protrusiva
- **Clase II** · relación retrusiva
- **Clase III** · relación vertical aumentada
- **Clase IV** · relación latero-protrusiva (relaciones laterales)
- **Clase V** · relación vertical disminuida

La presencia de factores emocionales (estrés, bruxismo de origen central) agrava y dificulta el tratamiento.

Fuente: Martínez Ross E. Rehabilitación y reconstrucción oclusal. Ediciones Cuéllar.

■■ IMPORTANTE — Morris no es Angle y no es Okeson

Son clasificaciones distintas que comparten números:

- **Angle (Clases I, II, III)**: describe la relación **anteroposterior de los primeros molares**. Es morfológica.
- **Morris (Clases I a V)**: describe los **obstáculos que desvían la mandíbula al cerrar**. Es funcional.
- **Okeson** no utiliza esta clasificación de Morris. Okeson organiza el diagnóstico por daño en músculos, disco, superficies articulares e inflamación, y enfatiza la capacidad de adaptación del sistema frente a fuerzas lesivas.

La confusión es real: la Clase I de Morris puede parecer una Clase III de Angle. **Siempre especifica de qué clasificación estás hablando.**

Clase I · Relación protrusiva

Cuando la mandíbula se acerca a su cierre oclusal, encuentra una prematuridad (generalmente unilateral) que la obliga a desviarse en dirección lateroprotrusiva. Los cóndilos se desplazan a posiciones ectópicas, lo que predispone a una oclusión no orgánica (no mutuamente protegida).

En muchos casos la prematuridad se localiza entre los primeros premolares. Puede confundirse clínicamente con una Clase III de Angle o con una oclusión cruzada anterior.

Clase II · Relación retrusiva

Existen contactos distales que obligan a la mandíbula a un deslizamiento posterior al cerrar. Los cóndilos son forzados hacia atrás, lo que puede comprimir los tejidos retrodiscales (zona muy vascularizada e innervada) y generar dolor o inflamación (retrodiscitis).

Clase III · Relación vertical aumentada

Ocasionada la mayoría de las veces por obturaciones o prótesis colocadas en supraclusión. Es una de las causas más frecuentes de iatrogenia en el consultorio. Por eso es obligatorio verificar la oclusión de toda restauración antes de despedir al paciente (papel de articular en céntrica y en movimientos).

Clase IV · Relación latero-protrusiva

También llamada relaciones laterales. La mandíbula es desviada hacia la derecha o hacia la izquierda durante el cierre final. Se presenta en oclusiones cruzadas posteriores (premolares o molares). Las cúspides antagonistas contactan y desvían la mandíbula a una posición lateroprotrusiva donde termina el cierre.

Esto impone un esfuerzo muscular continuo y mantiene en alerta al sistema neuromuscular, con posibles consecuencias en articulaciones y dientes (fuerzas lesivas laterales).

Clase V · Relación vertical disminuida

Puede ser causada por:

- Pérdida o falta de piezas posteriores (unilateral o bilateral)
- Desgaste oclusal o incisal excesivo (facetas patológicas por bruxismo)
- Erupción parcial de la dentadura permanente

Cuando hay masticación unilateral, el cóndilo del lado sin soporte puede desviarse hacia atrás y hacia la línea media por la contracción muscular sin apoyo dentario.

Relación con los conceptos de Okeson

Okeson (5.^a ed.) no clasifica las oclusiones patológicas en estas cinco clases. Su enfoque se centra en:

- **Criterios de oclusión funcional óptima** (Cap. 5): contactos estables en RC/MIC, guía anterior, ausencia de interferencias de balance.
- **Capacidad de adaptación**: una misma interferencia puede ser tolerada por un paciente y lesiva para otro.
- **Fuerzas lesivas**: magnitud, dirección, duración y frecuencia que superan la tolerancia de los tejidos.
- Diagnóstico por **estructura afectada** (músculo, disco, superficie articular, inflamación) más que por la dirección de la desviación.

Por tanto, usa Morris como herramienta didáctica local para entender desviaciones, pero el diagnóstico y el tratamiento definitivo deben guiarse por los principios de Okeson (historia, exploración, signos/síntomas y capacidad de adaptación).

Este material está disponible en la plataforma con ejercicios de autoevaluación y el asistente académico.
dentipedia.dentilike.com.mx

Dr. Miguel Alvarado Avilés · Catedrático